

на неправильно понятой концепции *rêverie* («Я не думаю, что каждому человеку выпадает двадцать четыре *rêverie* в день, даже если один раз в три месяца — это уже много. Вы не решаете все, что можно, с помощью *rêverie*, это не так работает... Это чрезвычайная ситуация, а не нормальная практика»); он разрушает миф о неуважении к пространству пациента (какой смысл тогда постулировать на метапсихологическом уровне существование реляционного, общего, интерсубъективного бессознательного?); он отвергает все еще упорное использование интерпретации для пациента того, что его «части» делают и чего не делают; он указывает на бесплодность любой теории поля, в которой нет места для онейрического в сессии (что является наиболее фрейдистской вещью из всех существующих: «Концепция поля, без открытости онейрическому, неизвестности и негативной способности, ожиданию, без концепции сновидения как трансформирующей деятельности, которая функционирует непрерывно, была бы очень обеднена»); он подчеркивает удовольствие от часа анализа; спокойно расчищает путь для анализа по Skype («Его можно проводить за столом, под столом, вися на люстре») и т. д.; он клеймит существование некоего культа тайны в мире психоанализа, в котором он видит парадоксальную социальную фобию самих аналитиков; он сетует («мне хочется плакать») на «безоговорочную» защиту национальной и даже местной традиции — как будто это сыр Grana Padano, а не качество аналитических исследований, где бы они ни проводились, и что чаще всего является не более чем симптомом печального и постоянного подчинения более титулованным зару-

бежным обществам и свидетельством провинциализма, который на самом деле так никогда и не был преодолен.

Лично меня озадачивает одна вещь: при сравнении моделей мы почти никогда не говорим подробно о клинике. Когда поступают Великие Возражения или отповеди, то всегда в форме разгромного лозунга. Самый известный или самый печально известный? Вот он: «Но реальность имеет значение!» Дело в том, что аналитики, теперь, когда даже маятник психиатрии качнулся в сторону биологии, чувствуют такую зыбкость почвы, на которую они опираются, вплоть до игнорирования того, что не существует единой теории бессознательного, а есть несколько и их нелегко интегрировать друг с другом, что они снова стали подчеркивать псевдореальность травмы. Я не хочу быть неправильно понятым: под приставкой «псевдо» я подразумеваю, что если психоанализ и имеет какую-то ценность, то только потому, что он «открыл» призрака. Притворяться, что не существует бессознательных оценок, имеющих отношение к «здесь и сейчас», о чем бы ни шла речь, и что прошлое, как хорошо объясняет Николи, не живет в настоящем, значит просто вернуться к временам до Фрейда и наивной и неполной теории реальной травмы.

Надо сказать, что критика не всегда исходит от аналитиков в фесках (некоторые из них предсказуемы, как пружинные роботы, и я не могу отрицать, что они вызывают у меня не очень большую симпатию). Иногда критика возникает из-за объективных концептуальных трудностей модели. Но я должен сказать, что часто она также возникает из-за благочестивой иллюзии, что достаточно прочитать две статьи или книги и, возмож-

но, получить две супервизии, чтобы понять глубокий, но контринтуитивный смысл определенного способа мышления о клинике, а также овладеть техникой, за которой стоит медленная и долгая эволюция. Конечно, это не так. Иногда в таких случаях мне приходится отвечать в стиле дзен, то есть не прямо: хорошо, научитесь играть на инструменте, фортепиано подойдет? Делайте упражнения, дойдите до того момента, когда вы настолько овладеете техникой, что сможете забыть о ней и достичь как можно большей спонтанности. В этот момент возвращайтесь и снова поговорим о теории и технике психоанализа.

Именно из-за этой трудности, присущей самой дисциплине, и вечно невыполнимой задачи, которую психоанализ возложил на себя — иметь дело с тем, что по определению не поддается немедленному познанию (*unbewusst*), читатель может с минимальными усилиями выяснить некоторые из самых сложных моментов теории аналитического поля, и удовольствие от погружения в оживленную беседу между Ферро и Николи является одной из сильных сторон книги.

Здесь красная линия, связывающая все главы, продолжается в следующей за интервью главе, посвященной теме раскрытия. Это важная тема сама по себе, и она особенно дорога автору, но здесь я бы предложил читать ее как разговор о «раскрытии» на сессии. Это вопрос о том, как выражать себя в целом на сессии и вне ее, например в письме; о том, что значит говорить и писать Языком Достижений (Бион), или говорить как в баре (Болоньини), или ненасыщенным (Ферро) и иносказательным образом.

Речь идет о важном развороте техники: в концепции терапевтического действия, которую мы имеем, интерпретация больше не является синтезом перевода из бессознательного в сознание, который в какой-то момент, возможно после месяцев молчания, сообщается пациенту; скорее, это восприимчивость к бессознательному, которая в целом остается личным делом аналитика, но из которой аналитик черпает вдохновение для успешного разговора (я имею в виду: который преуспевает в расширении психики через моменты единения, *at-one-ment*) и которая становится инструментом для психического роста. Я должен добавить, что с точки зрения поля ничто не является действительно частным, по крайней мере в своей бессознательной области, и что все, о чем думают, позитивно или негативно обуславливает эмоциональную атмосферу («О», «базовое допущение») сессии.

В чем же тогда заключается та инклюзивность, которую Николи хотел заложить уже в название? Я не думаю, что это тривиальная эклектика — разочаровывающий конформизм или политическое приспособленчество, ночь, когда все кошки серые. Скорее, я думаю, что это «поддержание онейрического», к чему Николи убедительно призывает, и, таким образом, вместе с Фростом, которого цитирует Огден, знакомство с ночью, галлюцинаторным, которое таится в восприятии, преодолевая или исследуя «цезуру; не аналитика, не анализанта; не бессознательное, не сознательное; не здравомыслие, не безумие. Но цезуру, связь, синапс, (контр-транс)-фер, переходно-непереходное состояние» (Бион).

Возможно, еще лучше нам объяснит это образ девочки, сидящей на подоконнике в оконном проеме. Теории

и модели в психоанализе — это как окна, выходящие на одну и ту же улицу, но под немного разными углами. Указатели пути, глаза, пороги. Но девочка читает. Хотя она, как тело и телесность, находится в ограниченной позиции, она погружена в другой мир, мир вымысла, и это и есть тот магический фильтр, или *луч тьмы*, с помощью которого она смотрит, не глядя на реальность улицы.

Некоторые из моделей психоанализа теперь предстают перед нами как низкие зарешеченные окошки, которые, вероятно, служат для того, чтобы освещать подвалы, и из которых вид на улицу неизбежно ограничен. Другие обещают нам более широкий и открытый вид. И все же некоторые будут довольствоваться взглядом через одно из двух закрытых окон, возможно, даже из-за полузадернутой занавески третьего. Почему девочка выбрала первое, мы не знаем. Зато мы знаем, что для того, чтобы занять такое положение, даже немного опасное (а ведь это всего лишь первый этаж), она открыла окно!

Январь 2023 года



Введение

Будьте с пациентом там, где он есть

Сцена первая

Я стою в дверях кабинета и жду мистера Капуто. Он один из первых моих пациентов, и я принимаю его еженедельно уже несколько месяцев. Это 50-летний механик, обратившийся ко мне из-за душевной боли, которую он никак не может унять: человек приземленный, он не привык заглядывать внутрь себя. Он уже год живет с иностранкой, страстной девушкой намного моложе его самого, но не может забыть свою бывшую жену. Он пребывает в мучительном тупике, не решаясь выбрать между двумя женщинами. Я слышу тяжелые шаги на лестнице, и появляется незнакомец. Ему тоже около пятидесяти, лицо мне незнакомо, ничем не примечательный, немного горбится.

— Доброе утро, доктор, меня зовут Бонанно, я друг Капуто. Он не смог прийти сегодня, и так как у меня тоже проблемы в отношениях, он спросил, не хочу ли я пойти вместо него, чтобы у вас не пропал сеанс, —

говорит он мне, как будто это самая естественная вещь в мире.

Я стою, окаменев, перед этим незнакомцем. Что мне делать? Что думать? Вежливо его отшить или...?

— Мистер Бонанно, проходите, давайте немного поговорим.

Сцена вторая

Около полудня я паркуюсь у дома Бьонды и звоню в дверь. За эти месяцы я весьма своевольно решил, что именно в это время начинается сессия. Ее муж, местный политик, открывает автоматические ворота; я прохожу внутрь и жду, пока он спустится и откроет мне входную дверь. Несмотря на установленное время сеансов, обычно мне приходится ждать его прихода несколько минут. Пару раз ожидание превышало три-четыре минуты: «Извините за откровенность, я был в одних трусах!» — оправдывается он. Поднимаясь по лестнице, я думаю об этом доме-замке, отгороженном от внешнего мира тремя входными дверьми, двухэтажном доме, в котором не установлено ни одного подъемника, несмотря на то что Бьонда уже несколько лет прикована к постели. По дороге в «комнату анализа» я порой встречаю главных героев истории пациентки: 24-летнего светло-волосого застенчивого сына пациентки, с которым мы торопливо здороваемся, или молчаливую и степенную старушку, живущую этажом ниже, ужасную мать, о которой рассказывает Бьонда.

Войдя в дом, который встречает меня теплым домашним запахом, я направляюсь в спальню, дверь в которую закрыта.

«Извините», — произношу я, как пароль. Слабый голос, все еще безликий, отвечает мне: «Входите...» — и я закрываю за собой дверь, единственный физический барьер, который защищает конфиденциальность аналитической встречи.

Сцена третья

Сан-Франциско, прохладный вечер в конце июля. Я в компании Томаса Огдена в его уютной отделанной деревом студии на Лорел-стрит. Мы уже час беседуем о привычке просить пациентов рассказывать свою историю во время первичных интервью. Эту тему я часто обсуждаю с молодыми коллегами, которых в аспирантуре учили составлять точный анамнез. У меня есть некоторые сомнения: не рискуем ли мы таким образом ограничить свободу пациента, не дав ему представить себя таким, какой он есть, показать себя так, как это кажется ему естественным? Не является ли личная история сознательным построением, которое может занять слишком много места и заставит пациента поверить, что нас интересует в основном это? Я сказал об этом Огдену, и вот наши последние реплики, как я их помню:

Томас Огден: Я думаю, что самое важное в нашей беседе с пациентом не связано с сознательным рассказом, а заключается в том, что аналитик должен сделать все возможное, чтобы заставить пациента рассказать нам о своем бессознательном опыте. Для меня попросить пациента рассказать мне историю его отношений с матерью во время первых интервью означает предложить ему перейти на сознательный уровень. Если я

спрашиваю его, почему он сделал или сказал что-либо, я неправильно понимаю цель анализа: когда аналитик спрашивает, почему, он подталкивает человека к сознательному мышлению, что подразумевает причинно-следственную связь.

Природа аналитической беседы не является объяснительной: я не помогаю пациенту понять, почему он или она что-либо делает, потому что эта форма общения является причинно-следственной, она линейна, а мы, как правило, не переживаем происходящее внутри нас посредством линейного мышления.

Лука Николи: Вы хотите сказать, что наша задача в том, чтобы создать нечто большее, чем открытие чего-то нового при выходе за рамки интерпретаций переноса? Мне вспоминается глагол «бессознавать», которым Чивитарезе обозначил конструирование опыта посредством бессознательного.

Томас Огден: Да. Для Фрейда психоаналитическая работа заключается в том, чтобы сделать бессознательное сознательным, а я думаю, что психоанализ позволяет сознательному стать бессознательным. Человек не делает что-то потому, что в прошлом он делал что-то другое, так как настоящее есть сумма всего, что было в прошлом, а все прошлое присутствует в этот момент. Каждая вещь, которая произошла когда-то, которая что-то значила для нас, жива и сейчас. Я говорю о поперечном измерении времени: сложность всего, чем является человек, не может быть раскрыта с помощью линейного мышления, потому что человек подобен картине. Я думаю об экспрессионистском искусстве Джексона Поллока: когда мы смотрим на одну из его картин, мы не спра-

шиваем, почему здесь тот или иной мазок или является ли одна деталь картины основанием для другой. Скрывается ли под ней то, что художник нарисовал раньше? Нет, вся картина целиком находится здесь, в настоящем моменте ее написания.

Чтобы пояснить замысел этой книги, я представил три сцены из далекого прошлого, которые свидетельствуют о том, что я всегда чувствовал необходимость найти правильный способ принимать других, помогать всем нуждающимся, чтобы никто не остался в стороне.

Отчужденность — это чувство, которое я всегда переживал очень болезненно. В первые годы моей карьеры огромные усилия, которые я приложил, чтобы начать свою карьеру психолога, прежде чем стать аналитиком, побудили меня искать пациентов где только возможно, не дожидаясь, пока они постучатся в мою дверь. Не было такого понятия, как «пациенты анализа», как обычно называют людей, которых считают подходящими для аналитического лечения; были люди, каждый из которых страдал по-своему, не зная, как исцелиться.

Чтобы они доверили себя заботе молодого психотерапевта, необходимо было донести до них в живой и понятной форме, что психоанализ — это не интеллектуальное упражнение, которое следует выполнять на дорогих кожаных шезлонгах в кабинете, где на тебя будет взирать свысока недоверчивый и суровый аналитик, как напоминают нам Чивитарезе и Ферро (2022), а захватывающее и смелое приключение в творческой и доброжелательной атмосфере, которое аналитик и пациент переживают вдвоем.

На YouTube есть видео, красивое и трогательное, в котором молодой аналитик Давид Россо помещает свою практику в центр квадрата, очертив границы с помощью скотча (рис. 1). Получается что-то вроде открытой коробки. Окружающие с любопытством наблюдают за этим странным явлением. Сначала возникает недоверие, некоторое сопротивление, пока испуганный ребенок в сопровождении матери не пересекает «стену» и не входит в «комнату». Тогда граница становится местом контакта, и начинается настоящий вихрь встреч: три девушки хотят посидеть в компании аналитика, молодой человек ложится на кушетку и с удовольствием беседует, и вскоре перед студией на площади образуется небольшая очередь.



Рис. 1. YouTube: Das Heimlich. Uncanny 2015. Edited by Davide Rosso

Эта сцена символизирует послание, которое я хочу донести до читателя: никакое наследие не выживет во времени, если оно остается замкнутым на себе, если оно

не способно переоткрывать себя, взаимодействовать с внешним миром, интерпретировать себя, не изменяя себе, адаптировать к новым условиям лучшее из того, что оно может предложить.

И подобно тому, как каждый аналитик знает, что он или она выйдет измененным из встречи с каждым пациентом, точно так же психоанализ в этом бурном веке пережил преобразования, пройдя через контакты с психотиками, с детьми и подростками, с институтциями, с нарциссическими веяниями в обществе, с клиникой опустошенности: порезами, анорексией, наркоманией, запоями. Это новые пограничные области.

С другой стороны, новое всегда рождается на границе, редко в центре. Работы, которые я представляю, родились на этих приграничных территориях, во время самых сложных встреч с пациентами, заставляющих аналитика усомниться в своей личной и профессиональной компетентности, идущих на шаг дальше последней страницы руководства по технике терапии.

Секретарша Пеннер

Тони — очень богатый нью-йоркский бизнесмен, настоящий гигант, облаченный в безупречный костюм от Армани. Решительный и динамичный, он обращается за онлайн-терапией к доктору К. после того, как другие врачи потерпели с ним неудачу: «Мне больше не нужны врачи, теперь я хотел бы поспорить с человеком, как с теми, кого я знаю по работе».

Стена эффективности рушится по ночам, когда появляются кошмары, атакующие Тони. В детстве он подвергался насилию, и эта травма все еще слишком остра.

На первом сеансе Тони не появляется и не предупреждает доктора К. Позже он пишет, что был несколько сбит с толку и попросил Пеппер, своего личного секретаря, позаботиться о встречах, чтобы избежать дальнейших проблем.

Через несколько недель Тони не приходит во второй раз; вскоре после этого он пишет, что забыл о назначенном сеансе, потому что не спал той ночью из-за кошмаров. Доктор К. отвечает, что у них будет возможность поговорить об этом при следующей встрече. Через час терапевт получает электронное письмо от Пеппер, в котором та сообщает, что две следующие встречи придется перенести.

Первое впечатление доктора К. состоит в том, что секретарь действует как элемент сопротивления пациента, чтобы избежать неприемлемых для него отношений зависимости. Когда ситуация становится сложной или неопределенной, на сцену выходит Пеппер. Доктор К. хотел бы очистить поле от нее, чтобы напрямую общаться с Тони по поводу оплаты, пропущенных сеансов и других аспектов сеттинга, поэтому он просит меня помочь разобраться с этим.

Можно объяснить Тони, что существенным компонентом работы является то, что все аспекты терапии, даже те, которые считаются бюрократическими, они будут решать вдвоем. Такое соглашение будет неоспоримым условием лечения. Если пациент будет возражать против этого условия, мы можем задаться вопросом: достаточно ли у него мотивации для работы, поддается ли пациент анализу?

Второй вариант, не менее правомерный, заключается в том, чтобы показать пациенту то, как он сопротивля-

ется развитию близких отношений с неизвестным человеком, которому предстоит доверить так много власти. «Тони, я понимаю, что вы можете чувствовать себя скованно, слишком тесно в отношениях, где нас только двое. В прошлом другие люди пользовались вами в силу своего положения. Однако признание этих страхов — необходимый шаг к тому, чтобы разобраться с кошмарами».

Мне было трудно выразить эту интерпретацию словами, потому что это не мой стиль. Такое вмешательство может стать рискованным на столь ранней стадии отношений и может подстегнуть потребность пациента защищаться от аналитика, например, вынудив его прекратить терапию.

Поэтому я без промедления ответил на опасения доктора К.: «Если Тони решил называть Пеппер рукой, которой он подписывает переводы и электронные письма, что в этом плохого? Это странно, я согласен, но я не думаю, что это проблема, которую нужно немедленно решать вместе с ним, а вы?»

Я предложил своему коллеге рассматривать Пеппер как персонажа в аналитическом поле, назначенного представлять Тони в его отношениях с внешним миром; в данный момент секретарь незаменим. Потом будет видно.

Эта сценка и множество других, которые я мог бы представить вам или которые вы могли бы представить мне, представляют собой срез новых форм встречи, ставших возможными благодаря развитию технологий и расширению контекстов применения психоанализа. Такие ситуации заставляют нас воспринимать пациента таким, каков он есть, и задаваться вопросом, насколько

ко далеко мы готовы отойти от своих привычек, чтобы встретиться с ним.

Классический психоанализ не смог бы легко принять такого рода отклонения от нормы: вы не можете устроить операционную в гараже! Существует теоретический и технический аппарат, наработанный десятилетиями, который обеспечивает определенный контроль над непостижимым разнообразием ситуаций, с которыми может столкнуться человек.

С одной стороны, адаптация нашей работы к новым клиническим условиям позволила необычайно усовершенствовать аналитическую технику. Если ребенок не может войти в кабинет, многие коллеги, в том числе и я, соглашались начать сеанс в приемной или на лестнице. Есть даже такие, кто явится домой к пациенту, если сочтет это необходимым, как я уже показывал в предыдущем эпизоде.

С другой стороны, несколько месяцев назад, обсуждая на клиническом совещании случай, в котором я допустил некоторую свободу действий при онлайн-встрече, одна из коллег возразила: «Да, пандемия сейчас благоприятствует дистанционной терапии, но это не значит, что пациенты могут делать все, что захотят, как будто ничего не случилось!»

Меня очень заинтриговала позиция коллеги, потому что мне показалось, что она смешивает предоставление пациенту некоторой свободы действий с игнорированием значимости происходящего. Наоборот, я считаю, что нужно признать: это не одно и то же.

Конечный смысл книги заключается в этом коротком и, казалось бы, простом предупреждении. Мы можем выйти за рамки привычного, но мы должны четко осоз-

навать, что это не одно и то же, и желательно, чтобы это предупреждение было постоянным напоминанием, с которым можно диалектически соотноситься. Пеппер — не Тони, с этим мы все согласны: разница в том, как мы приспосабливаем и используем этого персонажа в аналитическом поле.

Если мы позволяем этой защитной установке стать чем-то самим собой разумеющимся и пренебрегаем коммуникативной ценностью эпизода, мы в конце концов отдаляемся от нашего аналитического центра тяжести: как утверждает Чивитарезе (2018), когда нам не удастся вынести за скобки материальную реальность, все становится плоским и стерильным.

Пеппер — настоящая, из плоти и крови, секретарша, и она представляет собой сопротивление, от которого нужно избавиться. Однако если мы не даем пациентам проявить их меры предосторожности, которые являются единственным способом, позволяющим им жить, мы оставляем их за дверью или принимаем их лишь частично. Говоря по сути, можно отказаться от привычного и проверенного сеттинга, чтобы добраться до пациента туда, где он находится, при условии, что будут приняты во внимание три аспекта.

1. Не только пациентом, но и терапевтом движут бессознательные мотивы, которые как таковые не могут быть поняты заранее. Хотим ли мы избежать того, чтобы показаться негостеприимными и фрустрировать пациента? Хотим ли мы установить с ним особые отношения, отбросив обычные правила и привычки?

Работа без памяти и особенно без желаний невозможна. Мы должны принимать реальность наших же-

лений и мириться с тем, что априори не знаем наших бессознательных детерминант. Наивно думать, что они не имеют никакого влияния.

Именно неопределенность бессознательной переменной аналитика побуждала классический психоанализ к максимальному абстрагированию ценой того, что он казался слишком жестким. Сегодня мы можем отказаться от концепции отстраненности, если тщательно исследуем то, что происходит на сессии, используя такие ключи, в зависимости от нашей парадигмы, как мультиперсональное поле, со-конструирование, сно-видение сессии, реализация, коммуникативные проективные идентификации и контридентификации, контрперенос в самом широком понимании. Мы должны признать, что отчасти являемся бессознательными игроками в этой игре, совершенно не осознающими глубинных процессов, как указывает Антонино Ферро, с которым мы ведем диалог в главе 7.

2. Следование шаг за шагом заученным техническим приемам не освобождает нас от необходимости постоянно спрашивать себя, как мы принимаем пациента. Сеттинг и техника не вечны. С одной стороны, сегодня то, как мы ведем себя с пациентами, приобретает значение, по крайней мере, равное тому, что мы им говорим (Bolognini, Nicoli, 2022): истина, которую мы предлагаем как пищу, является таковой, только если она учитывает способность другого принять ее. Поэтому интерсубъективные, реляционные и интерпсихические модели неизбежны.

Более того, социокультурные рамки, в которых мы находимся, также меняются, и постоянные колебания не позволяют нам считать наши теоретические и техни-